



ANALISIS ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS DATA HASIL KEGIATAN KELURAHAN CANTIK 2026

KELURAHAN WALE
KECAMATAN WOLIO · KOTA BAUBAU



Analisis Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data Kelurahan Cinta Statistik Tahun 2026 – Kelurahan Wale

Katalog : -
Nomor Publikasi : -
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : ii + 6 halaman

Penyusun Naskah:

Mahasiswa Magang BPS Kota Baubau:

Dewi Maharani: D-III Statistika Universitas Halu Oleo

Penyunting:

Tim Pembina Desa Cantik BPS Kota Baubau:

L.M. Rizal, S.Tr.Stat. : Pembina Descan BPS Kota Baubau

Febiana Dahlia Anjani, S.Tr.Stat. : Pembina Descan BPS Kota Baubau

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com, canva.com

Sumber Data:

- Hasil Pendataan Pokelcan 2026 Kelurahan Wale
- Potensi Pembangunan Kelurahan Wale 2026

5 ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI RT 03/ RW 02

Topik masalah: Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Terkonsentrasi di RT 03/RW 02

Rincian data yang dipilih: Tabel Keberadaan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, sumber air minum tidak tersedia, dan sumber air minum tidak layak di RT; Tabel Keberadaan permukiman kumuh di RT; Tabel Keberadaan keluarga yang pernah mendapatkan program bantuan perumahan di RT setahun terakhir.

Latar belakang: Dari enam RT di Kelurahan Wale, hanya RT 03/RW 02 yang tercatat memiliki rumah tidak layak huni ("Ada, sebagian besar") sekaligus permukiman kumuh, dengan rincian 1 lokasi permukiman kumuh yang mencakup 55 bangunan rumah dan 64 keluarga. Angka ini signifikan karena RT tersebut hanya memiliki sekitar 68 keluarga menurut data kependudukan, artinya hampir seluruh keluarga di RT ini tinggal di permukiman kumuh. Yang memperparah kondisi ini, data juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun RT di Kelurahan Wale, termasuk RT 03/RW 02, yang keluarganya pernah menerima program bantuan perumahan dalam setahun terakhir. Kombinasi rumah tidak layak huni tanpa adanya intervensi bantuan menjadikan masalah ini masalah struktural yang berlarut tanpa penanganan.

seluruh 442 keluarga di kelurahan telah menikmati akses listrik PLN tanpa satu pun keluarga yang menggunakan listrik non-PLN atau belum teraliri listrik, serta tidak tercatat kejadian pencemaran air, tanah, maupun udara pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh di RT 03/RW 02 bukan disebabkan oleh keterbatasan akses listrik maupun pencemaran lingkungan, melainkan murni pada aspek kualitas fisik bangunan dan sanitasi. Kelurahan belum memiliki kegiatan pengolahan/daur ulang sampah maupun program pengelolaan lingkungan lain (penanaman mangrove, lubang biopori, dsb.), sehingga penanganan permukiman kumuh perlu diiringi inisiasi pengelolaan sampah berbasis komunitas yang memang belum tersedia di kelurahan.

Dampak dari masalah: : Jangka pendek, keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh lebih rentan terhadap gangguan kesehatan (ISPA, penyakit kulit, diare) akibat kualitas bangunan dan sanitasi yang buruk. Jangka panjang, permukiman kumuh yang dibiarkan dapat meluas ke RT-RT lain, menurunkan nilai aset properti warga, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah RT, serta menghambat capaian indikator pembangunan kelurahan terkait perumahan dan permukiman layak huni. Ketiadaan program pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan di tingkat kelurahan turut memperbesar risiko permukiman kumuh ini meluas ke RT lain apabila tidak segera diintervensi.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu mengusulkan RT 03/RW 02 sebagai prioritas utama dalam program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH) dan penataan kawasan kumuh ke Dinas Perumahan dan Pemerintah Kota, disertai pendataan by-name by-address keluarga penghuni permukiman kumuh agar pengajuan bantuan tepat sasaran. Kelurahan juga perlu memfasilitasi usulan program bantuan perumahan

(BSPS/bedah rumah) yang selama ini belum pernah masuk ke wilayah ini, serta mendorong perbaikan sanitasi dan akses air bersih di lokasi kumuh tersebut. Mengingat elektrifikasi rumah tangga sudah merata (442 dari 442 keluarga menggunakan listrik PLN) dan bukan menjadi kendala, solusi dapat difokuskan sepenuhnya pada rehabilitasi fisik rumah, perbaikan sanitasi, dan inisiasi pengelolaan sampah berbasis komunitas yang saat ini belum ada di kelurahan, tanpa perlu mengusulkan perluasan jaringan listrik.

2. PEMERATAAN LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA PEMANTAUAN MASALAH GIZI

Topik masalah: Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Belum Merata, Berkaitan dengan Temuan Kasus Stunting

Rincian data yang dipilih: Tabel Keberadaan Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang tinggal/menetap di RT; Tabel Jumlah Posyandu Aktif Dengan Kegiatan Tiap Bulan, Posbindu, dan Jumlah Kader Pelaksana menurut RT; Tabel Keberadaan dukun bayi/dukun bersalin, warga penderita stunting, dan penderita kekurangan gizi menurut RT.

Latar belakang: Data menunjukkan bidan yang tinggal/menetap hanya ditemukan di 1 dari 6 RT (RT 02/RW 02), sementara 5 RT lainnya tidak memiliki bidan yang berdomisili di wilayahnya. Posyandu aktif dengan kegiatan rutin tiap bulan juga hanya berjalan di 2 dari 6 RT (RT 03/RW 01 dan RT 03/RW 02), begitu pula Posbindu yang hanya aktif di 2 RT. Pada saat yang sama, kasus penderita stunting ditemukan di 4 dari 6 RT (RT 01/RW 01, RT 02/RW 01, RT 03/RW 01, dan RT 03/RW 02), termasuk RT 03/RW 02 yang juga bermasalah dengan permukiman kumuh. Pola ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan akses layanan kesehatan ibu dan anak yang lemah justru menjadi wilayah dengan temuan stunting.

meskipun tidak terdapat rumah sakit, klinik utama, maupun puskesmas di dalam wilayah kelurahan, seluruh fasilitas tersebut dapat dijangkau dengan kategori 'sangat mudah' pada jarak 1,1–2,7 km (rumah sakit 1,4 km; klinik utama 1,1 km; puskesmas rawat inap 2,7 km; puskesmas tanpa rawat inap 2,2 km; puskesmas pembantu 8,8 km); satu-satunya fasilitas dengan kategori 'sangat sulit' adalah balai kesehatan yang berjarak 99,7 km, namun kebutuhannya sudah tercakup oleh puskesmas dan klinik yang jauh lebih dekat. penurunan jumlah praktik mandiri bidan dari 1 menjadi 0 dan poskesdes dari 1 menjadi 0 dibandingkan tahun 2024, sejalan dengan temuan Pokelcan bahwa tidak ada satu pun RT yang memiliki bidan menetap pada 2026, sementara jarak ke praktik mandiri bidan (2,2 km) maupun poskesdes terdekat (2,5 km) tetap tergolong 'sangat mudah'. Dengan demikian, akar masalah bukan pada jauhnya fasilitas kesehatan rujukan, melainkan pada ketiadaan tenaga kesehatan yang berdomisili di RT serta rendahnya cakupan posyandu/posbindu rutin bulanan yang baru berjalan di 2 dari 6 RT.

Dampak dari masalah: Dalam jangka pendek, minimnya kehadiran tenaga kesehatan dan layanan posyandu/posbindu membuat pemantauan tumbuh kembang balita dan deteksi dini gizi kurang tidak berjalan optimal. Dalam jangka panjang, stunting yang tidak tertangani berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia generasi mendatang, termasuk kemampuan kognitif dan produktivitas saat dewasa, yang pada akhirnya menghambat pembangunan sumber daya manusia Kelurahan Wale secara keseluruhan. Perlu digarisbawahi bahwa dampak ini timbul bukan karena jarak tempuh ke fasilitas kesehatan rujukan yang jauh (seluruh fasilitas rujukan tergolong 'sangat mudah' dijangkau, 1,1–2,7 km), melainkan karena

minimnya tenaga kesehatan yang menetap di RT dan rendahnya frekuensi layanan promotif-preventif berbasis RT.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk menempatkan atau menugaskan bidan desa secara bergilir di RT-RT yang belum memiliki tenaga kesehatan menetap, serta mengaktifkan kembali kegiatan posyandu dan posbindu bulanan di seluruh RT, terutama di RT dengan temuan stunting. Kelurahan juga perlu mengusulkan program pemberian makanan tambahan (PMT) dan edukasi gizi keluarga secara rutin, dengan prioritas pada RT 01/RW 01, RT 02/RW 01, RT 03/RW 01, dan RT 03/RW 02. Karena akses jarak ke fasilitas kesehatan rujukan sudah tergolong sangat mudah, arah kebijakan tidak perlu diarahkan pada pembangunan fasilitas kesehatan baru di kelurahan, melainkan pada penguatan ketersediaan tenaga kesehatan berbasis domisili atau kunjungan terjadwal di tingkat RT, khususnya RW 02 yang sama sekali tidak memiliki tenaga kesehatan menetap.

3. PENINGKATAN KEANDALAN PASOKAN AIR LEDENG METERAN

Topik masalah: Pasokan Air Ledeng Meteran Belum Lancar di Seluruh RT

Rincian data yang dipilih: Tabel Tingkat kelancaran akses ledeng meteran sebagai sumber air minum atau memasak atau mandi/cuci.

Latar belakang: Seluruh 6 RT di Kelurahan Wale menggunakan ledeng meteran sebagai sumber air utama untuk minum, memasak, atau mandi/cuci, namun tidak satu pun RT yang airnya mengalir lancar setiap hari. Empat RT (RT 01/RW 01, RT 02/RW 01, RT 03/RW 01, RT 02/RW 02) hanya mendapat aliran air tiap 2 hari sekali, sedangkan 2 RT lainnya (RT 01/RW 02 dan RT 03/RW 02) bahkan hanya mendapat aliran air 2 hari dalam seminggu. Artinya, ketergantungan penuh warga pada satu sumber air utama tidak diimbangi dengan keandalan pasokan, sehingga seluruh wilayah kelurahan mengalami keterbatasan akses air bersih harian.

infrastruktur dasar kelistrikan sudah merata (442 dari 442 keluarga berlangganan PLN), namun pada aspek lingkungan tercatat belum ada satu pun kegiatan penampungan/pemanenan air hujan di kelurahan pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi ini relevan dengan masalah ketidaklancaran pasokan air ledeng meteran karena menunjukkan adanya potensi sumber air alternatif (air hujan) yang sama sekali belum dimanfaatkan sebagai solusi antara, sehingga perbaikan jaringan PDAM saja tidak cukup tanpa diimbangi diversifikasi sumber air di tingkat rumah tangga/RT.

Dampak dari masalah: Jangka pendek, keluarga harus menampung air dalam jumlah besar saat air mengalir, yang berisiko menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk dan menurunkan kualitas air akibat penyimpanan lama. Jangka panjang, keterbatasan pasokan air bersih dapat menghambat aktivitas ekonomi rumah tangga, meningkatkan beban pengeluaran keluarga untuk membeli air, serta memperbesar risiko penyakit berbasis air (diare, penyakit kulit) terutama pada RT 01/RW 02 dan RT 03/RW 02 yang kondisinya paling minim (hanya 2 hari per minggu).

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu mengusulkan kepada PDAM/BUMD Air Minum setempat untuk melakukan audit teknis jaringan distribusi dan penambahan kapasitas suplai ke wilayah Kelurahan Wale, dengan prioritas pada RT 01/RW 02 dan RT 03/RW 02 yang kelancaran nya paling rendah. Selain itu, kelurahan dapat mendorong pembangunan sarana

penampungan air komunal (tandon/reservoir RT) sebagai solusi antara agar warga tidak sepenuhnya bergantung pada jadwal aliran ledeng yang tidak menentu.

4. **PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN KESEHATAN DI RW 02**

Topik masalah: Ketidaktepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial (Exclusion Error DTSEN dan BPJS PBI)

Rincian data yang dipilih: Tabel Kependudukan terkait DTSEN pada 1 Juni 2026 (KK); Tabel Keberadaan penduduk yang seharusnya menerima BPJS PBI namun tidak menerima di RT.

Latar belakang: Data DTSEN menunjukkan adanya 17 keluarga yang seharusnya menerima bantuan sosial namun tidak menerima (exclusion error), terkonsentrasi di RW 02 (4 KK di RT 01/RW 02, 1 KK di RT 02/RW 02, dan 12 KK di RT 03/RW 02), serta 4 keluarga yang justru menerima bantuan padahal seharusnya tidak berhak (inclusion error). Selain itu, keberadaan penduduk yang seharusnya menerima BPJS PBI namun tidak menerima juga ditemukan di ketiga RT di RW 02 (RT 01, RT 02, dan RT 03/RW 02), sementara seluruh RT di RW 01 tercatat tidak mengalami masalah ini. Pola ini menunjukkan RW 02 secara konsisten menjadi wilayah dengan masalah ketepatan sasaran program bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

struktur ekonomi kelurahan yang didominasi sektor jasa dan nonpertanian (tidak ada satu pun keluarga pertanian dari 442 keluarga), dengan sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal seperti perdagangan, warung/kedai makanan, dan usaha mikro (34 unit industri mikro dan kecil). Karakteristik pekerjaan informal semacam ini membuat status kesejahteraan warga lebih sulit diverifikasi melalui indikator administratif formal, yang berpotensi menjadi salah satu penyebab tingginya exclusion error DTSEN yang terkonsentrasi di RW 02.

Dampak dari masalah: Dalam jangka pendek, keluarga yang seharusnya berhak namun tidak menerima bantuan sosial atau BPJS PBI kehilangan akses terhadap jaring pengaman sosial dan pelayanan kesehatan gratis, sehingga makin rentan terhadap guncangan ekonomi maupun biaya kesehatan mendadak. Dalam jangka panjang, exclusion error yang tidak diperbaiki dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan antar RT, terutama karena RW 02 sudah menghadapi masalah lain seperti permukiman kumuh dan minimnya tenaga kesehatan, sehingga risiko kemiskinan menjadi bertumpuk pada wilayah yang sama.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu melakukan pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN secara berkala bersama RT/RW, khususnya di RW 02, untuk mengoreksi exclusion error (17 KK) dan inclusion error (4 KK) yang sudah teridentifikasi, serta mengusulkan pendaftaran/aktivasi BPJS PBI bagi penduduk RW 02 yang seharusnya berhak namun belum terdaftar. Kelurahan juga perlu membentuk mekanisme pengaduan warga terkait bantuan sosial agar kasus-kasus ketidaktepatan sasaran dapat lebih cepat terdeteksi dan dilaporkan ke dinas terkait. Verifikasi lapangan sebaiknya turut mempertimbangkan karakteristik pekerjaan informal sektor jasa dan usaha mikro yang dominan di Kelurahan Wale,

agar penilaian kelayakan penerima bantuan tidak hanya bertumpu pada data administratif formal.

5. PENGUATAN MITIGASI BENCANA PESISIR DI RT 03/RW 02

Topik masalah: Kerentanan Bencana Pesisir Tanpa Sistem Mitigasi di RT 03/RW 02

Rincian data yang dipilih: Tabel Keberadaan kejadian/bencana alam di RT; Tabel Jumlah kejadian dan keberadaan korban bencana alam di RT; Tabel Keberadaan Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di RT.

Latar belakang: RT 03/RW 02 tercatat mengalami dua jenis bencana terkait wilayah pesisir dalam periode Januari-Desember 2025, yaitu gelombang pasang laut (1 kejadian) dan abrasi (1 kejadian), yang tidak dialami RT lain di Kelurahan Wale. Meski belum menimbulkan korban jiwa, kejadian ini menegaskan bahwa RT tersebut memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana pesisir. Namun demikian, data fasilitas mitigasi menunjukkan tidak ada satupun RT di Kelurahan Wale, termasuk RT 03/RW 02, yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam maupun perlengkapan keselamatan bencana. Rambu atau jalur evakuasi hanya tersedia di 3 dari 6 RT, dan RT 03/RW 02 tidak termasuk RT dengan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat terkait mitigasi bencana selama setahun terakhir.

Kelurahan Wale Tahun 2025 yang juga mencatat tidak adanya sistem peringatan dini bencana maupun peringatan dini tsunami serta tidak adanya perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.) di tingkat kelurahan, baik pada Podes 2024 maupun 2025, meskipun rambu dan jalur evakuasi bencana secara umum tercatat 'ada' di tingkat kelurahan. Publikasi tersebut turut mencatat belum adanya kegiatan pembuatan, perawatan, atau normalisasi infrastruktur pengendali bencana seperti tanggul, drainase, maupun perlindungan pantai, sehingga memperkuat urgensi rekomendasi mitigasi struktural, khususnya di RT 03/RW 02 yang menjadi satu-satunya wilayah dengan riwayat kejadian gelombang pasang dan abrasi.

Dampak dari masalah: Jangka pendek, tanpa sistem peringatan dini, warga di wilayah pesisir tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi maupunantisipasi kerusakan harta benda saat gelombang pasang atau abrasi terjadi kembali. Jangka panjang, abrasi yang terus berlangsung tanpa penanganan dapat mengikis garis pantai dan lahan permukiman warga secara permanen, sementara ketiadaan mitigasi dapat meningkatkan risiko korban jiwa maupun kerugian materiil yang lebih besar jika intensitas bencana pesisir meningkat akibat perubahan iklim.

Solusi/rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian masalah: Kelurahan perlu mengusulkan pembangunan sistem peringatan dini bencana alam dan penyediaan perlengkapan keselamatan dasar kepada BPBD, dengan prioritas pada RT 03/RW 02 sebagai wilayah dengan riwayat gelombang pasang dan abrasi. Kelurahan juga perlu menginisiasi kegiatan penguatan kapasitas masyarakat (sosialisasi kebencanaan, simulasi evakuasi) serta mengusulkan penanganan struktural seperti pemecah gelombang atau penanaman vegetasi pantai untuk mengurangi laju abrasi di wilayah pesisir tersebut.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

